

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

AES – Biologie et orientation

Accident d'exposition au sang ou à un liquide biologique : premiers soins, évaluation urgente et bilan initial.

Indications

- Piqûre, coupure ou morsure avec effraction cutanée.
- Projection sur œil ou muqueuse.
- Sang ou liquide biologique sur peau lésée.
- Exposition professionnelle ou non professionnelle récente.

Vérifications préalables

- Noter heure, mécanisme, profondeur, matériel, liquide et port de gants.
- Identifier la personne source si possible ; recueillir son accord pour les tests.
- Vérifier vaccination et immunité VHB de la personne exposée.
- Activer immédiatement le circuit AES/référent local.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas faire saigner. Plaie : eau + savon, rinçage, puis antiseptique 5 min selon procédure.
- Œil/muqueuse : rincer immédiatement et abondamment au sérum physiologique ou à l'eau.
- Avis expert le plus tôt possible, idéalement avant 4 h ; un TPE VIH n'est plus indiqué au-delà de 48 h.
- Déclaration d'accident du travail selon la procédure.

Intervention IDE

- Exposé : VIH Ag/Ac ; VHB (Ag HBs, anti-HBs, anti-HBc sauf immunité connue) ; VHC.
- Si TPE envisagé : créatinine/DFG, ALAT et test de grossesse si pertinent.
- Source, avec accord : VIH Ag/Ac rapide, Ag HBs, VHC ± ARN VHC selon circuit.
- Prélever sans retarder une première dose de TPE prescrite.

Surveillance et traçabilité

- Tracer circonstances, premiers soins, heures, résultats et avis reçus.
- Organiser le suivi prescrit, en général à S12 ; contrôle VHC plus précoce si source ARN VHC positive.
- Si TPE : surveiller tolérance et observance ; transmettre au référent.
- Archiver déclaration et résultats dans le dossier sécurisé.

Alerte immédiate

- Orientation urgente : exposition profonde, aiguille creuse, sang visible ou source VIH/VHB/VHC positive à risque.
- Appeler le 15 si accès au circuit impossible, exposition majeure ou malaise.
- Aucune prophylaxie VHC : le suivi biologique ne doit jamais être omis.

Mention de sécurité

Le bilan initial n'exclut pas une transmission et ne doit jamais retarder l'évaluation du risque. Toute décision de TPE relève d'un médecin/référent ; les prélèvements de la source exigent information et accord. Compte rendu IDE écrit, daté et signé au dossier.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :